

Alkohol i substancje

ChAD i alkohol to wyjątkowo niebezpieczna mieszanka — 40–60% osób z ChAD doświadcza zaburzeń używania substancji. Ten handout pokazuje mechanizm, ryzyka i konkretną drogę do zmiany.

CZAS: 25 min · przeczytanie **Codzienna decyzja** **ŹRÓDŁO:** Sonne & Brady (2002); Strakowski (2005)

JAK UŻYWAĆ

W ChAD podstawowa rekomendacja kliniczna to **całkowita abstynencja od alkoholu i substancji psychoaktywnych**. Powód: każda substancja zaburza rytm dobowy, neurochemię i interakcję z lekami. Nawet umiarkowane spożycie alkoholu (2–3 drinki tygodniowo) zwiększa ryzyko nawrotu. Jeśli pełna abstynencja jest obecnie nieosiągalna, cel pośredni: *jak najniższy próg* + zerowa tolerancja dla substancji psychoaktywnych innych niż leki przepisane. Każdy krok w stronę abstynencji daje wymierną korzyść.

DLACZEGO TO DZIAŁA

ChAD i zaburzenia używania substancji są **najczęstszą podwójną diagnozą w psychiatrii**: 40–60% osób z ChAD i doświadcza takich zaburzeń w ciągu życia (Regier 1990; Cassidy 2001). Mechanizm dwukierunkowy: substancje są często używane do *samoleczenia* objawów (alkohol w lęku, stymulanty w depresji), ale paradoksalnie **pogarszają przebieg**. Strakowski i wsp. (2005) wykazali, że jednocześnie zaburzenia używania substancji wiążą się z: szybszą zmianą faz, dłuższymi epizodami, większą liczbą hospitalizacji, słabszą odpowiedzią na lit, zwiększonym ryzykiem samobójstwa. Każdy unikany drink to nie tylko brak ryzyka — to aktywna ochrona neurochemii.

01 ✕ Cztery mechanizmy szkodliwości w ChAD

1 · ZABURZENIE RYTMU DOBOWEGO

Alkohol skraca fazę REM i fragmentuje sen. Wieczorny drink usypia, ale budzisz się w nocy. **Każde zaburzenie snu w ChAD = ryzyko epizodu.**

2 · INTERAKCJE Z LEKAMI

Alkohol *osłabia działanie* stabilizatorów nastroju i nasila ich skutki uboczne. Z litem może zaburzyć stężenie terapeutyczne — ryzyko zatrucia lub niedolitemii.

3 · ZNIEKSZTAŁCENIA POZNAWCZE

Alkohol obniża hamowanie korowe — w hipomanii dodatkowo. To **pomnaża** ryzyko impulsywnych decyzji finansowych, relacyjnych, seksualnych. Reguła 24h pod alkoholem nie działa.

4 · BEZPOŚREDNIO NA NEUROBIOLOGIĘ

Alkohol jest *neurotoksyczny*. W ChAD już występuje neuroprogresja (kindling) — alkohol ją przyspiesza. Substancje stymulujące (amfetamina, kokaina) wprost wyzwalają manię.

02 📊 Ranking ryzyka — od najgorszego

SKRAJNIE RYZYKOWNE

- Amfetamina, metamfetamina, kokaina — bezpośrednio wyzwalają manię
- Ekstazy (MDMA) — zaburza serotoninę, ryzyko zespołu serotonergicznego
- Halucynogeny (LSD, psylocybina) — ryzyko psychozy
- Sterydy anaboliczne, sterydy lecznicze

BARDZO RYZYKOWNE

- Alkohol w upijaniu się (≥4 drinki/sesję)
- Marihuana regularna — zwiększa ryzyko nawrotu manii o 2–3 razy
- Substancje OTC z pseudoefedryną
- Energetyki + alkohol

UMIARKOWANIE RYZYKOWNE

- Alkohol „społeczny” (1–2 drinki dziennie)
- Marihuana okazjonalna
- Duże dawki kofeiny (≥4 espresso dziennie)
- Nikotyna (efekt na sen, interakcja z lekami)

WZGLĘDNIE BEZPIECZNE (Z UMIAREM)

- Kawa 1–2 dziennie · przed 14:00
- Słaba herbata
- Sporadyczny kieliszek wina przy kolacji (jeśli stabilny rytm i bez leków przeciwwskazujących — konsultacja!)

03 → Krok po kroku — droga do ograniczenia

KROK 1 · MAPOWANIE AKTUALNEGO SPOŻYCIA

Przez 7 dni zapisuj *wszystko*: ile, kiedy, w jakiej sytuacji. **Bez oceny** — tylko fakt. Większość osób niedoszacowuje swoje spożycie o 30-50%.

KROK 2 · ROZMOWA Z PSYCHIATRĄ

Pokaż dziennik. Lekarz może: ocenić interakcje z lekami, sprawdzić, czy wymagana detoksykacja, zaproponować farmakoterapię uzależnienia (naltreksona, akamprozat dla alkoholu). **Nigdy nie odstawiaj alkoholu nagle** przy regularnym spożyciu — wymagany nadzór.

KROK 3 · CELE STOPNIOWE

Cele realistyczne, mierzalne, z terminem: np. *tydzień 1-2*: zero w dni robocze. *Tydzień 3-4*: maks. 1 drink w weekend. *Tydzień 5-8*: pełna abstynencja. Każdy krok celebrowany.

KROK 4 · WSPARCIE SPOŁECZNE

Anonimowi Alkoholicy (AA) lub SMART Recovery to dodatek do leczenia, nie alternatywa. Powiedz jednej osobie bliskiej o swoim celu. Pokoju spotkań AA znajdziesz na aa.org.pl.

KROK 5 · ZASTĘPCZE RYTUAŁY

Drink to często rytuał (po pracy, na imprezie, w samotności). **Zastąp rytuałem, nie pustką**: herbata, kąpiel, spacer, telefon do bliskiej osoby, czytanie. Mózg potrzebuje nagrody zastępczej.

04 💡 Sygnały — gdy używanie wymyka się spod kontroli

- ☐ Picie w samotności, w tajemnicy
- ☐ Picie rano albo „na kaca”
- ☐ Tolerancja rośnie — potrzeba więcej
- ☐ Niepowodzenia w próbach ograniczenia

- ☐ Konflikty z bliskimi z powodu picia
- ☐ Picie pomimo świadomości szkody
- ☐ Spadek funkcjonowania zawodowego
- ☐ Objawy odstawienia (drżenie, lęk, bezsenność)

3 lub więcej zaznaczone: rozmawiaj z psychiatrą *w tym tygodniu*. Skuteczne leczenie zaburzeń używania substancji w ChAD wymaga jednoczesnego podejścia — psychoterapia + farmakoterapia + wsparcie grupowe.

Klucz: w 5-letnim badaniu Salloum i Thase (2000) pacjenci ChAD, którzy osiągnęli pełną abstynencję, mieli **o 70% mniej hospitalizacji** i **4-krotnie mniejsze ryzyko samobójstwa** w porównaniu z aktywnie używającymi. Każdy krok ku abstynencji *natychmiast* poprawia działanie leków, jakość snu i stabilność nastroju. To jeden z najsilniejszych modyfikowalnych czynników rokowniczych w ChAD — silniejszy niż wybór konkretnego leku.